SALAIRE À VIE — UTOPIE RÉALISABLE

Et si votre hôpital n'avait plus besoin de faire du profit ?

Économie Socialisée · Gouvernance · Santé

CE QUE VOUS CONNAISSEZ

Sophie est infirmière depuis quinze ans. Son service de gériatrie vient de fermer, pas faute de patients, faute de rentabilité. Dans la clinique d'à côté, le directeur a supprimé des lits pour améliorer le ratio coût/séjour. À l'hôpital public du même département, la direction a imposé une cure d'austérité pour équilibrer le budget. Résultat identique : moins de soins, plus de pression, des patients renvoyés trop tôt chez eux.

> ***Public ou privé, le constat est le même : la santé se gère aujourd'hui comme une entreprise. Elle doit être rentable. Quand elle ne l'est pas, elle se réduit.***

CE QUE LE MODÈLE PROPOSE

Dans l'Économie Socialisée, la clinique est rachetée à son propriétaire au prix du marché, sans expropriation, et l'hôpital public change de logique de pilotage. Les deux deviennent des Unités de Production, gérées selon les mêmes principes.
Le lundi matin après la bascule : Sophie est toujours là. Les patients aussi. Les protocoles aussi. Ce qui a changé, c'est qui décide et pourquoi.

La direction privée ou le directoire nommé d'en haut est remplacé par un conseil de gestion élu par les soignants et les patients, avec des mandats courts et non renouvelables à l'infini. Personne ne répond à un actionnaire. Personne n'optimise un taux de remplissage. Les orientations ne viennent plus du marché mais d'une cartographie des besoins réels : combien de lits de gériatrie manquent dans ce territoire, où les déserts médicaux s'aggravent, quelles spécialités sont sous-dimensionnées. L'unité de production gère son quotidien en pleine autonomie, dans ce cadre.

CONCRÈTEMENT POUR VOUS

Le service de gériatrie de Sophie ne peut plus fermer parce qu'il n'est pas rentable. S'il manque de moyens, un protocole en 5 étapes s'enclenche : l'équipe s'auto-évalue, l'État audite sans sanctionner, le secteur santé réorganise si nécessaire, la région stabilise territorialement, et si besoin une caisse d'investissement finance les équipements.
Aucune faillite possible — seulement des ajustements. Sophie conserve son salaire, garanti à vie, quoi qu'il arrive.

OUI MAIS…

> ***« Sans la pression du marché, plus personne ne se bougera. Ça va devenir une administration à la soviétique. »***

C'est l'inverse qui est conçu : l'unité est autogérée par ceux qui y travaillent. Ce sont les soignants eux-mêmes et les patients qui siègent au conseil et décident de l'organisation interne, des rotations, des innovations. La pression ne vient plus d'un actionnaire lointain, mais de l'équipe et des usagers, au quotidien. Ce qui disparaît, c'est la contrainte de rentabilité. Pas la responsabilité.